

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Departamento de Vinculación con la Colectividad

Justificación Técnica de los Resultados y el Feedback de Cada Test

Herramienta Digital de Tamizaje de Salud Mental

Proyecto: Vinculación — 31796

Autor: Jonathan Jaguaco

Equipo: Equipo de Documentación

Fecha: Mayo 2025

Versión: 1.0

Documento interno de uso médico-asistencial.
No requiere conocimientos de programación para su lectura.

Contents

1	Propósito de Este Documento	3
2	Test PHQ-9 — Cuestionario de Salud del Paciente	3
2.1	¿Qué es el PHQ-9?	3
2.2	Estructura del test	3
2.3	Cálculo de la puntuación	3
2.4	Niveles de resultado y justificación	4
2.5	Criterio para los mensajes y sugerencias mostrados	4
3	Test BAI — Inventario de Ansiedad de Beck	4
3.1	¿Qué es el BAI?	4
3.2	Estructura del test	5
3.3	Cálculo de la puntuación	5
3.4	Niveles de resultado y justificación	5
3.5	Representación visual en el informe	5
3.6	Criterio para los mensajes y sugerencias mostrados	6
4	Consideraciones Generales para el Profesional de Salud	6
5	Resumen de Referencia Rápida	6
5.1	PHQ-9 — Puntos de corte	6
5.2	BAI — Puntos de corte	7

Propósito de Este Documento

Este documento está dirigido a los profesionales de salud que utilizarán o revisarán los resultados generados por la herramienta digital de tamizaje. Su objetivo es explicar, en términos claros y sin tecnicismos informáticos, las siguientes preguntas clave:

- ¿Qué test se aplicó y en qué se basa?
- ¿Cómo se calculó la puntuación del paciente?
- ¿Por qué el sistema le asignó ese nivel de resultado?
- ¿Qué significan los mensajes y sugerencias que se muestran?

Importante: Los resultados de esta herramienta son orientativos. No reemplazan el juicio clínico del profesional de salud ni constituyen un diagnóstico. Deben interpretarse como un primer filtro de tamizaje.

Test PHQ-9 — Cuestionario de Salud del Paciente

¿Qué es el PHQ-9?

El PHQ-9 (*Patient Health Questionnaire-9*) es un instrumento de tamizaje ampliamente validado para detectar síntomas depresivos en la población general. Fue desarrollado por Kroenke, Spitzer y Williams (2001) y cuenta con respaldo científico extenso para su uso en atención primaria.

La herramienta digital aplica la versión adaptada al español, con lenguaje accesible para personas mayores o con bajo nivel de escolaridad.

Estructura del test

El test consta de **9 preguntas**, cada una referida a síntomas experimentados durante las **últimas dos semanas**. Para cada pregunta, el paciente elige una de cuatro opciones:

#	Opción de respuesta	Puntaje
0	Ningún día	0
1	Varios días	1
2	Más de la mitad de los días	2
3	Casi todos los días	3

Cálculo de la puntuación

La **puntuación total** es la suma de los valores de las 9 respuestas, con un rango posible de **0 a 27 puntos**. A mayor puntuación, mayor presencia de síntomas depresivos.

Adicionalmente, el sistema calcula un **porcentaje de bienestar** que representa cuán alejado está el puntaje del máximo posible, según la fórmula:

$$\text{Bienestar (\%)} = \frac{27 - \text{Puntuación total}}{27} \times 100$$

Este porcentaje permite mostrar una escala visual intuitiva al paciente. Sin embargo, la puntuación clínica de referencia sigue siendo el puntaje directo.

Niveles de resultado y justificación

Puntaje	Nivel asignado	Justificación clínica
0 – 4	Buen equilibrio de ánimo	Ausencia o presencia mínima de síntomas depresivos. El paciente reporta funcionar bien en sus actividades cotidianas.
5 – 9	Días con altibajos	Síntomas leves que no interfieren significativamente con el funcionamiento diario, pero merecen seguimiento.
10 – 14	Algunos días pesan más que otros	Síntomas moderados. El paciente puede estar experimentando dificultades en sus actividades. Se recomienda evaluación más detallada.
15 – 19	Un poco de compañía podría hacerle bien	Síntomas moderadamente graves. Es probable que el paciente tenga una afectación funcional importante. Se sugiere intervención profesional.
20 – 27	Es tiempo de tomar un respiro	Síntomas graves. Alta probabilidad de depresión mayor. Se recomienda atención clínica oportuna y evaluación de riesgo.

Criterio para los mensajes y sugerencias mostrados

Los mensajes que el sistema muestra al paciente fueron redactados con un enfoque de comunicación no alarmista, especialmente adecuado para poblaciones adultas mayores o personas que podrían sentirse estigmatizadas por términos clínicos directos. Por ello:

- Se evitan palabras como “depresión”, “trastorno” o “enfermedad” en la comunicación directa al paciente.
- Los mensajes resaltan el valor de buscar apoyo y mantener hábitos saludables.
- Las sugerencias son orientativas y no prescriptivas; el médico sigue siendo la autoridad en el plan de atención.
- A medida que el puntaje aumenta, el tono de los mensajes se vuelve más cercano y empático, e incluye explícitamente la recomendación de buscar ayuda profesional.

Test BAI — Inventario de Ansiedad de Beck

¿Qué es el BAI?

El BAI (*Beck Anxiety Inventory*) es un instrumento estandarizado para medir la intensidad de síntomas de ansiedad. Fue desarrollado por Aaron Beck y colaboradores (1988) y es uno de los más utilizados en la práctica clínica y la investigación.

La versión implementada en la herramienta recoge síntomas somáticos y cognitivos de ansiedad experimentados durante la **última semana**.

Estructura del test

El test consta de **21 preguntas**. Para cada una, el paciente indica en qué medida le ha afectado ese síntoma:

#	Opción de respuesta	Puntaje
0	En absoluto	0
1	Levemente	1
2	Moderadamente	2
3	Severamente	3

Cálculo de la puntuación

La **puntuación total** oscila entre **0 y 63 puntos** (21 preguntas $\times$ máximo 3 puntos cada una). A mayor puntuación, mayor intensidad de síntomas ansiosos.

Niveles de resultado y justificación

Puntaje	Nivel asignado	Justificación clínica
0 – 21	Días de mayor calma	Nivel de ansiedad muy bajo o mínimo. Los síntomas reportados no superan la variabilidad normal del estado emocional.
22 – 35	Algunos momentos de inquietud	Ansiedad moderada. El paciente experimenta síntomas que pueden interferir con su bienestar cotidiano y merecen seguimiento.
36 – 63	Días emocionalmente difíciles	Ansiedad severa. Se recomienda evaluación clínica para descartar trastorno de ansiedad y considerar intervención.

Representación visual en el informe

A diferencia del PHQ-9, el sistema BAI no calcula un porcentaje de bienestar continuo. En su lugar, la barra visual que ve el paciente se posiciona en uno de tres puntos fijos según el nivel:

- **Ansiedad baja:** marcador al extremo derecho de la barra (mayor calma).
- **Ansiedad moderada:** marcador al centro de la barra.
- **Ansiedad severa:** marcador al extremo izquierdo de la barra (mayor tensión).

Esta representación simplificada fue elegida para evitar que el paciente interprete matices cuantitativos dentro de un mismo nivel clínico, lo que podría generar confusión innecesaria.

Criterio para los mensajes y sugerencias mostrados

Al igual que en el PHQ-9, los mensajes del BAI fueron redactados con un lenguaje no alarmista. Se prioriza:

- Validar la experiencia del paciente sin magnificarla.
- Promover hábitos de autocuidado como primer paso accesible.
- Recomendar apoyo profesional de forma clara pero sin generar angustia adicional en los niveles más altos.

Consideraciones Generales para el Profesional de Salud

- 1. Los resultados son un punto de partida, no un diagnóstico.** El sistema de tamizaje permite identificar pacientes que podrían requerir una evaluación más profunda. La interpretación clínica final siempre corresponde al profesional tratante.
- 2. El lenguaje del sistema está adaptado para el paciente, no para el clínico.** Los niveles mostrados al paciente (por ejemplo, “Días con altibajos”) son traducciones comunicacionales de los rangos clínicos estándar. Para la documentación clínica, debe usarse la puntuación numérica directa y los criterios validados de cada escala.
- 3. La accesibilidad fue una prioridad de diseño.** El sistema incluye lectura en voz alta y opciones visuales de respuesta, lo que amplía su uso a personas con dificultades visuales o baja alfabetización digital. Esto no afecta la validez del resultado.
- 4. Los datos son temporales por privacidad.** Los resultados se almacenan de forma temporal en la sesión del navegador y no se conservan automáticamente. Se recomienda registrar el puntaje numérico al finalizar la prueba si se desea incorporarlo al historial clínico.

Resumen de Referencia Rápida

PHQ-9 — Puntos de corte

Puntaje	Nivel clínico estándar	Etiqueta mostrada al paciente
0 – 4	Mínimo / sin síntomas	Buen equilibrio de ánimo
5 – 9	Leve	Días con altibajos
10 – 14	Moderado	Algunos días pesan más
15 – 19	Moderadamente grave	Un poco de compañía podría hacerle bien
20 – 27	Grave	Es tiempo de tomar un respiro

BAI — Puntos de corte

Puntaje	Nivel clínico estándar	Etiqueta mostrada al paciente
0 – 21	Ansiedad mínima	Días de mayor calma
22 – 35	Ansiedad moderada	Algunos momentos de inquietud
36 – 63	Ansiedad severa	Días emocionalmente difíciles